

Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamine ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis



Karin Hanga, PH.D

Artiklis antakse lühiülevaade autori poolt 2018. a juunis Tallinna Ülikoolis kaitsstud doktoritööst „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamine ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis”. 2018. aasta detsembris pälvis doktoritöö Eesti Teaduste Akadeemia igaaastasel riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil peapreemia. Doktoritöö terviktekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Sissejuhatus

Teame, et puudega ja krooniliste terviseprobleemidega inimeste arv Eestis ja paljudes teistes maailma riikides kasvab. Analüüsides selle põhjusi, toovad nii maailmas kui Eestis läbi viidud uuringud välja samu tegureid: rahvastiku vananemine (vanaduses on kõrge risk tervisest tingitud tegevusvõime languseks), paranenud diagnoosimisvõimalused ja inimeste teadlikkus. Suurenenud on haigestumine mitmesse kroonilisse haigusesse nagu diabeet, südame- ja veresoonehaigused, vähk, kasvaja ning mitmesugused psüühikahäired, mis on peamised puude põhjustajad. (Statistikaamet 2018; Maailmapank ja WHO 2011). Veel kinnitavad uuringud, et puuetega inimesed kogevad ühiskonnas nii füüsilisi kui ka sotsiaalseid takistusi avalike teenuste kasutamisel (tervishoid, haridus, tööelu, kultuur, transport, informatsiooni

kättesaadavus jm). Neil on puudeta inimestega võrreldes halvem tervis, madalam haridustase ja tööhõive ning sellest tulenevalt kõrgem vaesusrisk. (Aaviksoo jt 2011; Flèche ja Radziwill 2012; OECD 2009a ja 2009b; Sotsiaalministeerium 2016; Tartu Ülikool ja Saar Poll 2009). Nimetatud probleemid on mitmetahulised ning lahendusi leidmata on oht, et paljude puuetega inimeste potentsiaal jääb kasutamata ning nad ei saa anda oma panust ühiskonna arengusse.

Üheks võimaluseks parandada puuetega inimeste ühiskonda kaasamist on inimese abivajadusele vastav rehabilitatsioon. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (2006) kohaselt on rehabilitatsiooni eesmärk võimaldada puuetega inimestel saavutada ja säilitada maksimaalne iseseisvus, täielik füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja ametialane võimekus ning kaasatus ja

osalemine kõigis eluvaldkondades. Maailma Terviseorganisatsioon (2017) täpsustab, et rehabilitatsiooni vahe-eesmärgid on seotud inimese keha struktuuride ja funktsioonide¹ arendamise ja ümberkujundamisega; võimete, tegevuse ja osaluse arendamisega ning inimese tegevusvõimet piirava keskkonna kohandamisega. Lihtsamalt tähendab see, et rehabilitatsioon peaks toetama inimest tema muutunud olukorraga kohanemisel, oma elu mõtestamisel ja psühholoogilise tasakaalu saavutamisel. Selle kaudu jõuab inimene selgusele, milliseid sotsiaalseid rolle ta oma elus soovib kanda ja omandab nende täitmiseks vajalikke oskusi. Rehabilitatsiooni tulemusel saab inimene olla iseseisvam ja oma eluga rahul. (Anthony ja Farkas 2009; Wilken ja Den Hollander 2005).

Doktoritöö uurimisülesanded

Doktoritöö keskendub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele ja täisealistele puuetega inimestele Eestis. See koosneb kolmest rahvusvahelisest eelretsenseeritud teadusartiklist (avaldatud 2015, 2016 ja 2017) ning analüütilisest kokkuvõttest, milles:

- 1) esitatakse töö teoreetilised ja metodoloogilised lähtekohad
- 2) antakse ülevaade sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamisvahendi arendamisest ja katsetamisest Eestis aastatel 2010–2015
- 3) esitatakse koondanalüüs hindamisvahendi piloteerimise kolmes etapis osalenud 489 puuetega inimese vajadustest ja ühiskonnaelus osalemisega seotud piirangutest ning inimeste poolt seatud rehabilitatsioonieesmärkidest
- 4) tehakse ettepanekud, milline võiks

olla rehabilitatsiooniteenus(t)e sisu, et nimetatud piirangutega igakülselt tegeleda

- 5) esitatakse soovitusel, kuidas kujundada terviklik rehabilitatsiooniteenus ja osutada rehabilitatsiooniteenuseid isikukeskselt, tunnustades inimese enda otsustavat rolli rehabilitatsiooniprotsessis.

Doktoritöö uurimisülesanded olid järgmised:

- 1) teha kindlaks, millistes peamistes eluvaldkondades oli uurimuses osalenud puuetega inimeste funktsioneerimisvõime kõige enam piiratud ning mis olid piirangute põhjused
- 2) pakkuda välja, kuidas kujundada rehabilitatsiooniteenuste sisu selliselt, et need aitaksid inimestel ületada kogetud piiranguid mitmekülgse multidistsiplinaarse rehabilitatsiooni abil
- 3) saada ülevaade esmastest eesmärkidest, mida inimesed ise rehabilitatsioonile püstitasid
- 4) teha ettepanekuid, kuidas kujundada ja osutada puuetega inimestele suunatud teenuseid isikukeskselt.

Puude ja rehabilitatsiooni mõistete kujunemine

Puude ja rehabilitatsiooni mõisted on alates 1960. aastatest teinud läbi olulise arengu. Peamised märksõnad on üleminek tervisekahjustuse põhiselt ehk meditsiiniliselt käsitluselt sotsiaalsele ning uue, biosühhosotsiaalse käsitluse väljatöötamine. Viimane kujutab endast terviklikku lähenemist, mis rõhutab, et puude täielikuks

¹ Organismi struktuurid on keha anatoomilised osad, nagu elundid, jäsemed või nende osad; funktsioonid on elundisüsteemide füsioloogilised talitlused (k. a psüühilised funktsioonid).

mõistmiseks ja asjakohaste rehabilitatsioonimeetmete planeerimiseks (ehk funktsioneerimisvõime arendamiseks) tuleb tervisega seotud tegurite kõrval (organismi struktuurid ja funktsioonid) hinnata ka inimese tegevus- ja osalusvõimet, füüsilise ja sotsiaalse keskkonna ning isiksuslikke tegureid. (WHO 2002; Hanga 2015). Biopsühhosotsiaalne käsitlus on läbiv ka rahvusvahelises funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioonis (edaspidi RFK, WHO 2001), mis kujutab endast raamistikku inimese funktsioneerimisvõimega seotud info süstematiseerimisel ja seetõttu sobib kasutamiseks rehabilitatsioonis. Selleks et hinnata funktsioneerimist võimalikult mitmekülgset ja ühtsetel alustel, töötas WHO välja puude hindamise küsimustiku (ingl WHODAS 2.0, *Dissability Assessment Schedule*), mis kuulub ühe osana Eestis kasutusele võetud rehabilitatsioonivajaduse hindamisküsimustiku koosseisu (WHO 2010). Üstün jt (2010) toovad välja, et WHODAS 2.0 võimaldab standardiseeritult hinnata inimese toimetulekut kuues eluvaldkonnas: kognitiivsed võimed, liikumine, enese eest hoolitsemine, kaasinimestega lävimine, argielu toimingud (kodus, koolis/tööl) ja ühiskonnaelus osalemine. Need on olulised valdkonnad, millega rehabilitatsioon tegeleb.

Rehabilitatsiooni kujunemist on mõjutanud humanistliku sotsiaaltöö põhimõtted, mille kohaselt on iga inimene väärtus; talle on omane arenguvõime ja soov ennast teostada. Inimest tuleb käsitleda tervikuna ja vastastiktoimes oma keskkonnaga. Spetsialisti tegevuse aluseks on inimese kogemuse mõistmine, toetuse ja empaatia väljendamine. (Emener 1991; Carter 2015). Rehabilitatsioonis on vaatluse all inimene kui tervik koos oma sotsiaalse ja füüsilise keskkonnaga; toetatakse inimese

eneseteostust, pakkudes talle tuge näiteks psüühilise tasakaalu saavutamisel ja oskuste arendamise kaudu.

Samuti on rehabilitatsiooni mõjutanud isikukeskse teenuse osutamise põhimõtted (Lauver jt 2002; Leplege jt 2007; McPherson ja Siegert 2009; Pryor ja Dean 2012). Need on järgmised: 1) iga inimene on ise oma elu ekspert, tal on keskne roll oma vajaduste määramisel ja valikute tegemisel; 2) teenuste kavandamisel ja osutamisel tuleb maksimaalselt arvestada inimese eelistuste ja muutuvate vajadustega, pidades seejuures silmas ka inimese vastutust oma valikute eest; 3) spetsialist peab olema empaatiline ja suutma luua toimiva koostöösuhte, kus vastutus kliendi ja spetsialisti vahel on otstarbekalt jagatud; 4) inimest jõustatakse, et ta oleks valmis vastu võtma oma elu puudutavaid otsuseid ja osalema rehabilitatsiooniprotsessis. Mida sisulisemalt on inimene kaasatud oma vajaduste määramisse ja valikute langetamisse ning valmis ise seadma endale edasise tegutsemise eesmärgi, seda pühendunum on ta rehabilitatsiooni eesmärkide elluviimisel (Anthony ja Farkas 2009; Pryor ja Dean 2012).

Arendusuuring

Arvestades doktoritöö praktilist eesmärki – töötada välja täisealiste puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsioonivajaduse eelhindamise küsimustik ja seda testida –, lähtuti uurimuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel arendusuuringu (ingl *developmental research design*) põhimõtetest. Dodd ja Epstein (2012) selgitavad, et selle fookuses on teoreetiline lähenemine, millele tuginedes töötatakse välja uus, innovaatiline lahendus konkreetsetele praktilise elu probleemidele. Arendusuuringule on iseloomulik tsükliline lähenemine: 2010. aastal toimus

celuuring ning aastatel 2011–2015 piloteerimine kolmes etapis. Arendusuuringu teostas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ning rahastas Euroopa Sotsiaalfond, sotsiaalministeerium kasutas selle tulemusi sisendina sotsiaalhoolekande seaduse muutmisel.

2015. a lõpuks valminud rehabilitatsioonivajaduse hindamisvahend (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2015) koosneb neljast osast:

- 1) üldandmed: isiku- ja demograafilised andmed, perekonnaseis, tööalane staatus, haridus ja huvialad, elukorraldus ja elukohas esinevad takistused
- 2) senini osutatud abimeetmed: millist abi ja teenuseid on inimene viimase kahe aasta jooksul kasutanud ning kuidas need on mõjutanud tema toimetulekut
- 3) toimetulek peamistes elualdkondades – 36 küsimust (WHODAS 2.0)
- 4) hindamise kokkuvõte: inimese esmane rehabilitatsioonieesmärk, juhtumikorraldaja hinnang inimese valmisolekule seatud eesmärgi täita, kaalutlusotsus teenusele suunamise/mittesuunamise kohta ning tegevuskava, mis hõlmab soovitusi inimese edasist toimetulekut toetavate teenuste osas.

2016. aastal jõustusid töövõimereformi osana sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille järgi sotsiaalkindlustusamet alustas täisealiste puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse eelhindamisega üle Eesti.

Andmete kogumine ja analüüsimine

Arendusuuringu eri etappides kasutati peamiselt kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid – fookusgrupi- ja individuaalset intervjuerimist, kusjuures intervjuud

sisaldasid nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid, mida analüüsiti eri meetoditega (statistiline analüüs ja kvalitatiivne sisuanalüüs).

2011.–2015. aastal viisid rehabilitatsioonispetsialistid või juhtumikorraldajad läbi 489 puudega inimese rehabilitatsioonivajaduse eelhindamise silmast silma intervjuu vormis. Intervjuude tulemuste põhjal valmis andmebaas, mida analüüsiti nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete meetoditega. Seejärel kogus uurimuse autor rehabilitatsioonispetsialistidelt ja juhtumikorraldajatelt tagasisidet individuaal- ja fookusgrupi intervjuude kaudu ning täiendavalt viis läbi poolstruktureeritud süvaintervjuud 12 hindamises osalenud puudega inimesega, et koguda nende tagasisidet hindamisprotsessile.

Tulemused

Piirangud peamistes elualdkondades

Kõigis kolmes piloteerimise etapis olid WHODAS 2.0 küsimustikuga hinnatud kuuest elualdkonnast inimestel kõige rohkem häiritud osalemine ühiskonnaelus, liikumine ning igapäevased toimingud (kodus, tööl).

Ebastabiilne tervis kui peamine toimetuleku piirang

Oli mitmesuguseid põhjusi, miks inimeste funktsioneerimisvõime oli häiritud, kuid kõige sagedamini oli see seotud inimese **tervisega ja vaimse tervise probleemidega**. Inimeste kommentaarid osutasid, et nad hindasid oma tervise olukorda ebastabiilseks, tundsid kroonilist valu (liigeseprobleemid, seljaprobleemid), tasakaaluhäireid ja kiiret väsimist; nad ei mõistnud oma haigusega kaasnevaid sümptomeid või olid sümptomid ebaselged; inimesed ei olnud olukorraga kohanenud ega julgenud võtta ette tegevusi väljaspool kodu, kartes, et

olukord võib ootamatult halveneda.

Ka **liikumise** puhul kirjeldati erinevaid tervisega seotud vaegusi: tasakaaluhäireid, valusid (puusas, seljas, põlvedes jt liigestes), hingeldamist, jõu kadumist, nõrkust, südamepekslemist, pearinglust ja kukkumiskartust. **Vaimse tervise probleemidest** kirjeldati pingeid ja ärevust uutes olukordades ja teiste inimestega suhtlemisel, oskamatus tulla toime ühiskondlike ootuste ja negatiivsete mõtetega.

Veel selgus kommentaaridest, et tervisest tingitud piiranguid võimendasid nii kodus kui väljaspool kodu mitmesugused **füüsilise keskkonna takistused**, mis tingis vajaduse abistaja, tehniliste abivahendite ja kohanduste järele. Sellisteks takistusteks olid näiteks trepid; käsipuude, kaldteede ja liftide puudumine; raskesti avatavad uksed; ligipääsetava transpordi ja puhkamiseks sobivate istekohtade vähesus.

Kommentaaridest selgus, et funktsioneerimist piirasid ka **emotsionaalsed probleemid**: tahtejõu puudumine, madal motivatsioon ja enesehinnang, (enese)stigmatiseerimine, enda (muutunud välimuse) häbenemine, varasemad negatiivsed kogemused ja halvasti ütlemine teiste inimeste poolt. Samuti selgus, et inimestel napib sotsiaalseid oskusi (kuidas suhelda kaasainimeste ja kolleegidega, hoida häid suhteid pereliikmete ja varasemate sõpradega, kuidas lahendada igapäevaelus ettetulevaid olukordi, küsida abi) ning puudespetsiifilisi oskusi (eeskätt olukorras, kus puue on äsja tekkinud). Mainiti ka **ebapiisavaid materiaalseid ressursse**, et ühiskonnaelus täisväärtuslikult osaleda.

Inimeste rehabilitatsioonieesmärgid

Analüüs hõlmas uurimuses osalenud inimeste esmaseid rehabilitatsioonieesmäärke:

uuriti, milline on inimeste ootus rehabilitatsioonile ja mida nad sooviksid selle abil oma toimetulekus muuta.

Kuigi sotsiaalse rehabilitatsiooni kaudu ei pakuta tervishoiuteenuseid, seadsid uurimuses osalejad ise kõige sagedamini eesmäärke seoses **tervise taastamise, stabiliseerumise või säilitamisega**. Inimesed soovisid, et olukord oleks võimalikult stabiilne, et nad suudaksid tulla toime valudega ja taastuda. Tervise paranemist või stabiliseerumist nähti paljudel juhtudel teiste eesmärkide saavutamise eeltingimuseks (nt elamise ja töötamise valdkonnas). Sageduselt teisena nimetati **eluoluga seotud eesmäärke**: inimesed soovisid omandada oskusi iseseisvaks toimetulekuks, et vähendada kõrvalabi vajadust.

Harvemini nimetati **töötamise või hariduse omandamisega** seotud eesmäärke, mis võib tuleneda kartusest seada tööalaseid eesmäärke enne, kui tervise või elamisega seotud probleemid on leidnud rahuldava lahenduse.

See, et tervisega seotud eesmäärke püstitati kõige sagedamini, viitab mitmele asjaolule.

- 1) Probleemid tervisega mõjutavad otseselt inimese toimetulekut eri eluvaldkondades (igapäevased kohustused, ühiskonnaelus osalemine, töötamine jm).
- 2) Senised teenused ja abi tervise stabiliseerimiseks või olukorraga kohanemiseks ei ole olnud piisavad.
- 3) Inimesed peavad tervist sotsiaalsest toimetulekust ja töötamisest prioriteetsemaks.
- 4) Inimestel on ootus, et rehabilitatsiooniteenus raames tegeldakse ka tervise parandamisega.

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kasutamine

Analüüsidest puuetega inimeste kogemusi seoses teenuste kasutamisega ilmnes, et alati inimesed ei tundnud, et teenused oleksid nende jaoks jõustavad ja isikukesksed. Neli peamist probleemide rühma hõlmasid esiteks **teabe puudust**: inimestel ei olnud küllaldaselt infot oma haiguse/puude kohta, nad ei saanud vajalikku infot pärast diagnoosi selgumist või ravi ajal; samuti nappis teadmisi, kuidas oma puude või haigusega toime tulla ning kuidas taotleda tervise või igapäevase toimetuleku parandamiseks vajalikke teenuseid. Teiseks, **mittetoetav koostöösuhe spetsialistiga**. Uurimuses osalenud inimesed märkisid, et nad ei tundnud, et spetsialistid neile piisavalt tähelepanu pööraksid ja neid mõistaksid, nad olid tunda saanud pealiskaudset suhtumist. Kolmandaks, **vähene koostöö teenuse osutamise käigus**. Inimesed märkisid, et sageli nad ei julge küsimusi esitada ning on tundnud teenuse osutamise ajal häbimärgistamist, üleolevat või alavääristavat kohtlemist. Neljandaks kirjeldati **süsteemi puudusi teenuste osutamisel ja korraldamisel**: järjekorrad, paindlikkuse ja ressurside puudumine, teenuste mahupiirangud.

Varasemate teenuste kasutamise kogemuste põhjal esitati ka positiivseid kommentaare, mis puudutasid nt mõningate teenuste mõju inimese toimetulekule või võimalust saada teenuseid meeldivas ja toetavas keskkonnas.

Isikukeskse teenuse komponendid

Puuetega ja teistele haavatavas positsioonis inimestele suunatud teenused peavad olema väärikad ja inimest jõustavad. Läbiviidud intervjuude alusel kujunes töös neli kategooriat tingimustest, mis peavad

olema täidetud, kui soovime pakkuda abi isikukeskselt.

- 1) Võtmetähtsusega on tekitada spetsialisti ja teenuse kasutaja vahel **tugev koostöösuhe ja partnerlus**. Spetsialistilt eeldab see rehabilitatsioonialast pädevust ja väljaõpet, klienditöös eetiliste põhimõtete ja väärtuste järgimist, austust inimeste erinevuste suhtes ja toetust; riigilt aga teenuse osutamist toetava keskkonna loomist.
- 2) Isikukeskne teenus näeb ette, et mõistetak **inimeste individuaalseid vajadusi, leitaks paindlikke lahendusi ja et teenuse maht oleks piisav**. See eeldab inimese vajaduste terviklikku käsitlemist, sh varem kogutud andmete kasutamist; teenuste sisu ja mahu individualiseerimist ning vajadusel inimese abistamist teenuste koordineerimisel.
- 3) Inimestele tuleb pakkuda **asjakohast ja piisavat informatsiooni** nende tervise olukorrast, olemasolevatest teenustest, õigustest ja kohustustest ning eneseabi ja toetusgruppidest, mis oleks edastatud neile arusaadaval viisil eri infokandjate kaudu.
- 4) Isikukeskse abi neljandaks osiseks on **jõustamine ja oskuslik vastutuse suunamine inimesele endale** oma elu juhtimise eest. Seda toetab võrdsusele tuginev koostöösuhe ning inimese tunnustamine omaenda elu eksperdina, mis suurendab inimese eneseusku ja kaasatust kõigisse teenusega seotud kavandamis- ja otsustusprotsessidesse.

Kokkuvõte

Uurimuses osalenud täisealiste puuetega inimeste üheks peamiseks funktsioneerimisvõimet raskendavaks teguriks olid **tervisega seotud piirangud**, mis põimusid keskkondlike ja isiksuslike teguritega. Läbi

viidud hindamisintervjuud ja täiendavad süvaintervjuud tõid selgelt esile, et tervisemurede meditsiinilistele lahendustele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Sellises olukorras ei ole inimene valmis püstitama laiemaid sotsiaalseid eesmärgi ühiskonnas osalemiseks (nt töötamine). See kinnitab, et funktsioneerimisvõime arendamiseks pakutavad teenused peavad olema integreeritud ja lahendama probleeme komplekselt. Seetõttu tuleks sotsiaalses või tööalases rehabilitatsioonis tegelda mitte üksnes sotsiaalse toimetuleku või töötamisega seotud asjaoludega, vaid ka igapäevast elu ja töötamist takistavate terviseprobleemidele lahenduse leidmisega. Siin on oluline nii juhtumikorralduslik abi, et siduda inimene tervishoiuteenustega, kui ka rehabilitatsiooniteenuse osana tervisealane nõustamine. Inimesele tuleb haigusteadlikkuse suurendamiseks pakkuda asjakohast ja arusaadavat teavet, kogemusnõustamist ning arendada praktilisi oskusi, mis aitavad tal haiguse või puudega toime tulla. Kuivõrd haiguse/puudega kohanemine mõjutab olulisel määral inimese enesehinnangut ja identiteeti ning sotsiaalseid suhteid, on rehabilitatsiooni ülesanne pakkuda tuge ka emotsionaalse tasakaalu ja eneseusu taastamiseks. See hõlmab oma elu mõtestamist, valmisolekut muutusteks isikliku elu ja tööga seotud rollides ning motivatsiooni toetamist. Alles seejärel saab tegelda otseselt sotsiaalsete või tööalaste eesmärkide ja tegevustega.

Tervisega seotud raskuste ületamise sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni käigus muudab keeruliseks asjaolu, et Eesti õigusruum, teenuste korraldus ja rahastus eristavad selgelt meditsiinilist, sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni, mida koordineerivad kolm riigiasutust – haigekassa, sotsiaalkindlustusamet ja töötukassa –, kasutades igaks erinevaid suunamisviise ja

rahastuspõhimõtteid. Seetõttu lahutatakse kehtivas rehabilitatsiooniteenuste korralduses inimese sotsiaalsed, tervise ja tööga seotud vajadused ning sageli ei tunnistata, et need on omavahel seotud. Nii on keeruline läheneda inimese rehabilitatsioonivajadustele terviklikult, õigeaegselt ja isikukeskselt. Piirid sotsiaal-, tööturu-, hariduse- ja tervishoiuteenuste vahel on vajalikud, kuid rehabilitatsiooni valdkonnas on need mõneti kunstlikud, sest inimese tervisest tingitud vajadusi on väga keeruline jaotada puhtalt meditsiinilisteks, sotsiaalseteks ja tööalasteks. Praegu kaotame väärtuslikku aega ega saavuta loodetud tulemusi, suunates inimest teenustele, mis ei tegele tema vajadustega terviklikult ja õigeaegselt ega toeta teda muude vajalike teenuste kättesaamisel.

Ettepanekud rehabilitatsioonisüsteemi kujundamiseks

Puuetega inimese abistamine peab alguse saama tugevast kohalikust omavalitsusest, mis on esmaselt vastutav abimeetmete olemasolu ja pakkumise eest. Kui kohalikud ressursid on ebapiisavad ja/või inimese olukorra lahendamiseks on vaja spetsiifiliste ekspertteadmistega meeskonda, siis suunatakse inimene rehabilitatsioonile.

Üheks võimaluseks on kujundada selline sujuv ja vajaduspõhine rehabilitatsiooni korraldus, mis võimaldaks kliendi juhtum koos vajalike taustaandmetega „üle anda” ühe valdkonna rehabilitatsioonisüsteemist teisele. Andmete üheseks mõistmiseks ja vahetulemuste hindamiseks tuleks nii sotsiaalses, meditsiinilises kui ka tööalases rehabilitatsioonis kasutada RFKd. Teise võimalusena võiks kaaluda ka ideed, et inimesele koostatud multidistsiplinaarne rehabilitatsiooniplaan sisaldaks samaaegselt kõiki nimetatud kolme rehabilitatsioonivaldkonna

teenuseid, mida on vaja tema rehabilitatsioonieesmärgi saavutamiseks. Vastutus rehabilitatsiooniteenuste koordineerimise ja rahastamise eest võib olla endiselt jagatud eri riigiasutuste vahel, kuid sellisel juhul on vaja kokkulepet, et kõik teenuste rahastajad – haigekassa, töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet – tunnustavad samade nõuete alusel ja kvalifitseeritud spetsialistide poolt koostatud rehabilitatsiooniplaani ja selles märgitud teenuseid. Iga valdkond vastutab plaani selle osa elluviimise eest, mis kuulub tema rahastamisvaldkonda. Eesmärk on, et inimene saaks tema vajadustele vastavat abi kiirelt ja piisavas mahus ning et terviklik, kindlaks perioodiks koostatud rehabilitatsiooniplaan võimaldaks inimese rehabilitatsioonivajadused rahuldada, ilma inimest

erinevatele rehabilitatsiooniteenustele suunamata, väärtuslikku aega kaotamata ning kartmata, et inimene satub praeguste teenuste vahel eksisteerivasse „lõhesse”.

On selge, et vaja on kokkulepet, mille on läbi arutanud ja heaks kiitnud kõik puudega inimestele rehabilitatsiooniteenuste osutamise ja rahastamise eest vastutavad osapooled: kuidas rehabilitatsiooniteenusele suunatakse, milliseid teenuseid osutatakse ja kuidas hinnatakse nende teenuste tulemuslikkust.

Vaja on ka sidusat käsitlust, kuidas vähendada praegust dubleerimist ja vastutuse hajumist. Selleks tuleks luua kõrgetasemeline tööühm, mis esindab kõiki sidusrühmi, sealhulgas puuetega inimesi ning Eesti ja rahvusvahelisi eksperte. **S**

Viidatud allikad

- Aaviksoo, A., Kruus, P., Leppik, L., Sikkut, R., Veldre, V., Võrk, A.** (2011). Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. Uuringu lühiversioon Tallinn: Praxis. www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tervishoid/Eesti_sotsiaalkindlustussusteemi_jaetkusuutliku_rahastamise_voimalused_luehiversioon.pdf. (29.04.2019).
- Anthony, W. A., Farkas, M. D.** (2009). Primer on the psychiatric rehabilitation process. Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation. Boston University. www.psychodyssey.net/wp-content/uploads/2011/10/Primer-on-the-Psych-Rehab-Process.pdf (29.04.2019).
- Astangu Kutsererehabilitatsiooni Keskus** (2015). Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine. Hindamismetoodika. Hindamisküsimustiku kasutusjuhend. www.astangu.ee/fileadmin/media/Astangu/Dokumendid/Taienduskoolitus/Sotsiaalse_rehabilitatsiooni_vajaduse_hindamise_metoodika_2015_.pdf (29.04.2019).
- Carter, S.** (2015). Humanism. Research Starters: Education.
- Dodd, S. J., Epstein, I.** (2012). Practice-based research in social work. London. Routledge.
- Emener, W. G.** (1991). Empowerment in Rehabilitation: An Empowerment Philosophy for Rehabilitation in the 20th Century. *Journal of Rehabilitation Oct-Dec*, 91, 57(4).
- Flèche, S., Radziwill, A.** (2012). Reducing poverty in Estonia through activation and better targeting. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1008, OECD Publishing. www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/reducing-poverty-in-estonia-through-activation-and-better-targeting_5k8xb72v68bx-en#.WmmuO5OFjOQ#page1. (29.04.2019).
- Hanga, K.** (2015). Rehabilitatsioonivajaduse hindamine 2015. Kokkuvõtte projekti tegevustest ja tulemustest. Astangu Kutsererehabilitatsiooni Keskus: Tallinn. www.astangu.ee/fileadmin/media/Astangu/Dokumendid/Taienduskoolitus/Rehab_vaj_hindamise_pilootprojekti_kokkuv%C3%B5te_Astangu2015_.pdf (29.04.2019).

- Lauver, D. R., Ward, S. E., Heidrich, S. M., Keller, M. L., Bowers, B. J., Flatley Brennan, P.** (2002). Patient-centred interventions. *Research in Nursing and Health*, 25, 246–255.
- Leplege, A., Gzil, F., Cammelli, M., Lefevre, C., Pachoud, B., Ville, I.** (2007). Person-centredness: Conceptual and historical perspectives. *Disability and Rehabilitation*, 29(20–21), 1555–1565. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922326 (29.04.2019).
- McPherson, K. M., Siegert, R. J.** (2009). Person-centered rehabilitation: Rhetoric or reality? *Disability and Rehabilitation*, 29(20–21), 1551–1554.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).** (2009a). Tackling the jobs crisis. Pathways onto (and off) disability benefits: Assessing the role of policy and individual circumstances. Kogumikus: OECD Employment Outlook 2009. www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2009/pathways-onto-and-off-disability-benefits_empl_outlook-2009-5-en. (29.04.2019).
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).** (2009b). Sicknes, disability and work. Keeping track in the economic downturn. www.oecd.org/employment/emp/42699911.pdf (29.04.2019).
- Pryor, J., Dean, S. G.** (2012). The person in context. Kogumikus: Dean, S. G., Siegert, R. J., Taylor, W. J. (toim.), Interprofessional rehabilitation. A person-centered approach. A John Wiley & Sons, Ltd.
- Sotsiaalministeerium** (2016). Töövõimereform. www.sm.ee/et/toovoiimereform (29.04.2019).
- Statistikaamet** (2018). Sotsiaalelu, tervishoid. http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/13Tervishoid/03Puudega_inimesed/10Uldandmed/10Uldandmed.asp.
- Tartu Ülikool ja Saar Poll.** (2009). Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/piu2009_loppraport.pdf (29.04.2019).
- Wilken, J. P., Den Hollander, D.** (2005). Rehabilitation and recovery. A comprehensive approach. Amsterdam: SWP Publishers.
- World Bank, World Health Organization.** (2011). World report on disability.
- World Health Organization (WHO).** (2017). Rehabilitation in health systems. World Health Organization Geneva.
- World Health Organization (WHO).** (2010). Disability assessment schedule 2.0. Geneva. www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/ (29.04.2019).
- World Health Organization (WHO).** (2002). Towards a common language for functioning, disability and health: ICF. Geneva. www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1 (29.04.2019).
- World Health Organization (WHO).** (2001). International classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva: World Health Organization.
- ÜRO** (2006). Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. RT II, 04.04.2012, 6
- Üstün, T. B., Kistanjsek, N., Chatterji, S., Rehm J.** (toim.). (2010). Measuring health and disability. Manual for the WHO Disability Assessment Schedule WHODAS 2.0. Geneva: World Health Organization. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547598_eng.pdf (29.04.2019).